

NS YH480C*227310502

EVANDRO CORDEIRO DE OLIVEIRA

IDADE: 51 PESO: 100 ALTURA: 184 PROFISSÃO: Prof.
 SINTOMAS: Sonolência / cansaço / Depressão
 QUEIXAS: Problema p/ dormir e manter o sono
 MEDICAMENTOS:

MÉDICO: Dr. Marcelo Naldi

EXERCÍCIO FÍSICO: Caminhador

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S

HORA QUE DORME:

HORA QUE ACORDA:

COCHILHO () SIM () NÃO

DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: IV

IAH: 20.8

SPO2: 85%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

sinusite

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

Rinite

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

29/08 - max. nasal N30"m" + Yuell - Auto.

05/09 P = 6.9 cmH₂O
 23 IAH = 1.2 e/ev

m. de uso: 5h29'

fua.

19/09 P = 4 cmH₂O
 23 IAH = 0.7

m. de uso: 7h

fua

17/10 P = 7.0 cmH₂O → teve um problema na
 23 máscara
 aparelho e um IAH = 20.5.

fua

09/11 P = 8.0 cmH₂O.
 23 IAH = 0.6 e/ev

m. de uso: 5h.

Bem adapt. e/der na coluna e sinusite

site

fua.

05/04 P = 8.0 cmH₂O
 24 m. de uso: 6h
 IAH = 0.4 e/ev
 Bem adaptado

Toco o BOSO.

fua

07/06 P = 8 cmH₂O
 24 IAH = 0.4 e/ev
 m. de uso: 5h32'
 Fuga = 18 e/pm.

fua.

26/08
24

P: BemH2O
m. de uso: 4hr
Fuga = 14.4 lpm
IAH = 0,1 efer

Relata que a alergia no
frio está pior.

dua

Nome: EVANDRO CORDEIRO DE OLIVEIRA

Data de Nascimento: 27-7-1972

IMC: 29,54

Sexo: Masculino

Data do exame: 27-03-2023

Peso: 100 kg

Altura: 1,84 m

Médico: DR. MARCELO NAOKI SOKI

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 27-03-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 568,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 195,5 e 284,0 minutos. O tempo total de sono foi de 309,0 min, eficiência de 54,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,1%; estágio N2: 58,9%; estágio N3: 22,0%; sono REM: 16,0%. O índice de despertares foi de 6,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 20,8/hora, sendo 47 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 18 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 85%, permanecendo 0,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 53 - 75 bpm e NREM de 54 - 77 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (04), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 20,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=85%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco durante o sono.

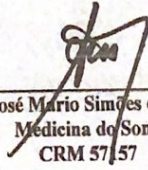
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157